Сеченовский Университет

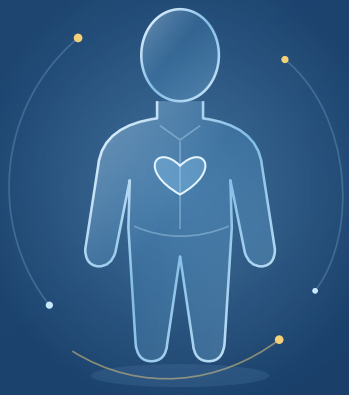
Институт аналитической токсикологии

МетаboСкан

ДЛЯ ПАЦИЕНТА

MS(PU)-003-T0

Рапорт для пациента



Ваш метаболомный профиль: кровь и утренняя моча

Что показали два анализа вместе, что это значит для вас и что делать дальше

ВАШ МЕТАБОЛОМНЫЙ СРЕЗ · ПЛАЗМА + УТРЕННЯЯ МОЧА

Хороший запас прочности

Обмен веществ работает с запасом и по крови, и по тому, что выводится с мочой. Задача — сохранить это и не растратить.

Зоны внимания: кишечник · иммунитет и стресс.

кровь — что циркулирует сейчас

моча — что организм вывел за ночь

Один профиль · два биоматериала



Плазма крови

Утренняя моча

Один момент времени

Это не динамика и не прогноз: рапорт описывает состояние на дату сдачи.

Понятный маршрут

Сначала — смысл результата, затем действия на ближайший период и первый врач.

ПАЦИЕНТ	ВОЗРАСТ / ПОЛ	МАТЕРИАЛ	ДАТА ЗАБОРА
Пациент-1	**42 года · Ж**	**плазма крови + утренняя моча · точка T0**	**07.10.2026**

Отчёт носит информационный характер и отражает функциональное состояние организма по метаболомному профилю крови и мочи. Он не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Все решения о лечении принимает ваш лечащий врач.

СПРАВОЧНАЯ СТРАНИЦА · О МЕТОДЕ

МетабоСкан: как устроен метод

Метаболом — малые молекулы, участвующие в обмене веществ. Плазма отражает их циркулирующий пул в момент забора, утренняя моча — след выведения за несколько часов. Здесь — принципы метода; индивидуальные результаты приведены в следующих разделах отчёта.

Как проходит исследование

Схема метода, не данные конкретного пациента

01 Два материала
Плазма крови и утренняя моча

→

02 Измерение
Малые молекулы обмена · ВЭЖХ-МС/МС

→

03 Сопоставление
Профиль обмена и клинический контекст

УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР · НЕ РЕЗУЛЬТАТ ПАЦИЕНТА

Четыре сочетания состояния и мочевого следа

	Мочевой след не усилен	Мочевой след выражен
Плазма спокойна	**Выраженного сигнала нет** В пределах этой пробы	**Возможная цена выше** Состояние может удерживаться с повышенной нагрузкой
Плазма с напряжением	**Сдвиг состояния** Не означает нарушения выведения	**Сдвиг и выраженный след** Обсудить оба ракурса вместе с врачом

Это основные сочетания, а не диагноз. «Цена» - гипотеза, не измерение затрат: учитывают питание, нагрузку, питьевой режим, почки и условия сбора.

Возможности метода

Ранний сигнал

Метаболомный профиль может показывать функциональные сдвиги, которые не отражаются в стандартных анализах; их значение уточняет врач. Многое здесь меняется режимом, питанием, сном, нагрузкой.

Понятные приоритеты и маршрут

Отчёт помогает выделить зоны внимания и сформулировать вопросы для приёма. Врач сопоставляет их с жалобами, анамнезом и обычными анализами.

Точка отсчёта

Одно исследование описывает один момент времени. Повтор при сопоставимых условиях позволяет оценить изменения; срок определяют по клинической задаче.

Границы метода

- Не ставит диагноз. Отклонение показателя — это сигнал для проверки, а не болезнь.
- Не заменяет обычные анализы крови и мочи и осмотр врача — он подсказывает, что именно стоит проверить.
- Не назначает лечение и добавки. Всё, что описано как «обсудить с врачом», требует очной консультации.

Четыре понятия для чтения отчёта

- **Референсный диапазон**
  Лабораторный коридор значений; выход за него не является диагнозом.
- **Нормировка на креатинин**
  Уменьшает влияние концентрации мочи, но не исключает влияние питьевого режима, мышечной массы и питания.
- **Шкала 0–10 (кровь)**
  Выше балл — больше расчётный ресурс системы.
- **Активность следа (моча)**
  Выше балл — заметнее мочевой след; это не шкала затрат.

Темп метаболического старения

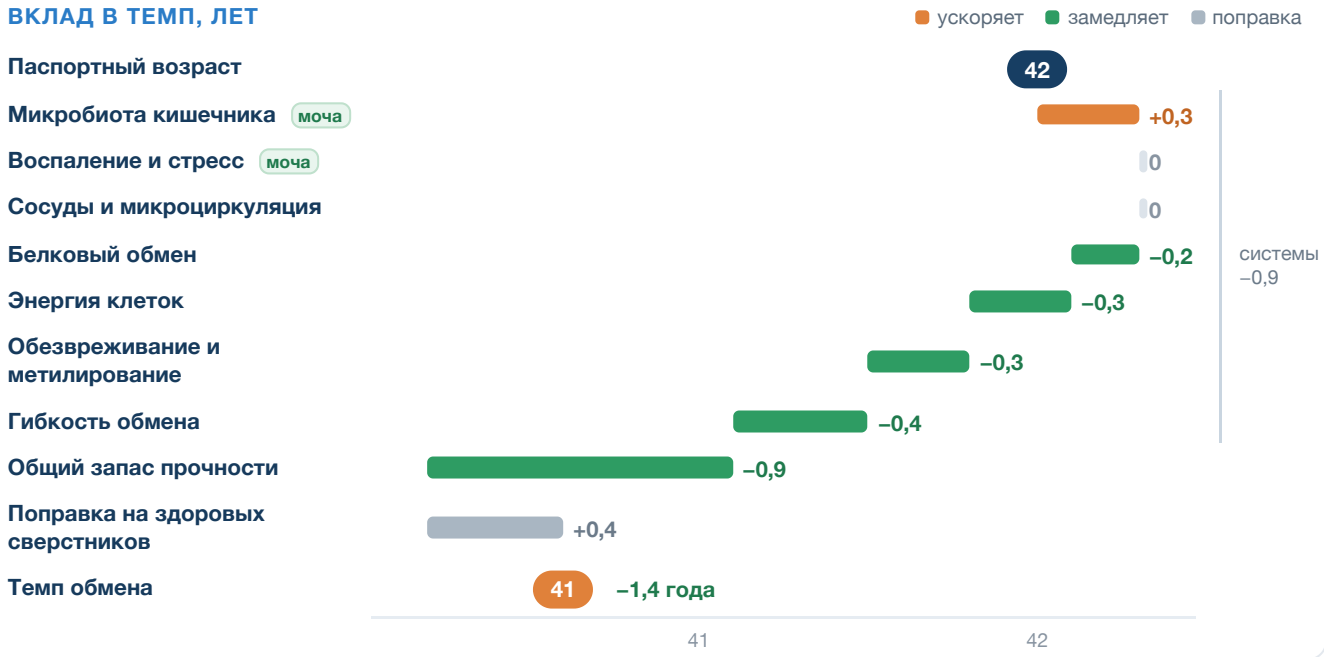
Это не биологический возраст по ДНК и не диагноз, а темп, с которым обмен расходует запас прочности. Он считается по тем же показателям, что и остальной отчёт, и большая часть его обратима.

42 ПАСПОРТНЫЙ ВОЗРАСТ → **41** ТЕМП ОБМЕНА



Обмен работает как у человека 41 лет — на 1,4 года меньше паспортного возраста. Это оценка темпа, а не утверждение, что организм буквально стал старше.

ВКЛАД В ТЕМП, ЛЕТ



ГЛАВНЫЕ РЫЧАГИ

+0,3 **Поработать с питанием кишечника**
больше клетчатки и разнообразия, меньше алкоголя и ультраобработанной еды

ОБРАТИМОСТЬ

Большая часть сдвигов сейчас обратима: они держатся на образе жизни и питании, а не на устойчивых изменениях. Это хорошее время действовать — эффект будет виден быстро.

Надёжность расчёта высокая: данных панели хватило для всех систем.

Первый контроль: через 8–12 недель после начала изменений, или по рекомендации врача

Как это считается. Вклад каждой системы считается по её показателям и переводится в годы; сумма вкладов и даёт разницу с паспортным возрастом. Это отдельная модель, её оценки не равны «Карте систем организма». Отметка «моча» у системы означает, что её независимо показывает и мочевая панель. На годы это не влияет: темп считается по плазме.

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ · ПЛАЗМА + УТРЕННЯЯ МОЧА · T0

Кровь и моча: два взгляда на один обмен

Одна строка — одна система. Сначала посмотрите кровь, затем мочу и общий смысл справа.

Кровь · запас системы
Какой запас у системы?
• **Балл выше → запас больше**

Моча · след обмена
Что след говорит о цене состояния?
◆ **Балл выше → след заметнее**

Обе шкалы от 0 до 10, но смысл разный. Баллы крови и мочи напрямую не сравнивают.

СИСТЕМА	КРОВЬ	УТРЕННЯЯ МОЧА	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ВМЕСТЕ
Кишечник	**5,0** /10 умеренное напряжение 0 — 10	**6,3** /10 высокий 0 — 10 След работы кишечных бактерий	**Сигнал в двух материалах** С этой системы стоит начать обсуждение с врачом.
Иммунитет и стресс	**9,5** /10 высокий резерв 0 — 10	**3,6** /10 заметный 0 — 10 След обмена триптофана	**Сигнал только в моче** Состояние сохранно; проверить возможную цену его поддержания.
Белок и мышцы	**8,1** /10 в норме 0 — 10	**0,6** /10 спокоен 0 — 10 След распада белка	**Без совместного сигнала** Система работает с запасом.
Очистка организма	**8,9** /10 в норме 0 — 10	**0,0** /10 спокоен 0 — 10 След «очистки» и антиоксидантной защиты	**Без совместного сигнала** Система работает с запасом.
Энергия и «топливо» клеток	**9,0** /10 высокий резерв 0 — 10	**0,0** /10 спокоен 0 — 10 Энергетический след (цикл Кребса)	**Без совместного сигнала** Система работает с запасом.
Сосуды и доставка кислорода	**10,0** /10 высокий резерв 0 — 10	**0,0** /10 спокоен 0 — 10 След обмена оксалатов (щавелевой кислоты)	**Без совместного сигнала** Система работает с запасом.

Как это читать. Спокойная плазма не всегда означает низкую «цену» состояния: выраженный мочевой след может указывать на повышенную нагрузку при сохранном состоянии. Это гипотеза, не измерение затрат: учитывают питание, нагрузку, питьевой режим, почки и условия сбора. Ни один вариант не является диагнозом.

Цифры вашего анализа

Кровь

155	19	9
измерено	вне референса	в зоне риска по Z

Утренняя моча

105	14
измерено	вне референса

Число отклонений — не степень тяжести: важно, какие показатели изменены и в какой системе.

Как мы считаем. Каждый показатель входит в подсчёт один раз (повторы объединяются); «вне референса» — значение за пределами лабораторного интервала (микроотклонения «на границе» не считаются); «зона риска» — $|Z| \geq 2$. Показатели мочи пересчитаны на креатинин: это уменьшает, но не убирает влияние того, насколько концентрирована проба.

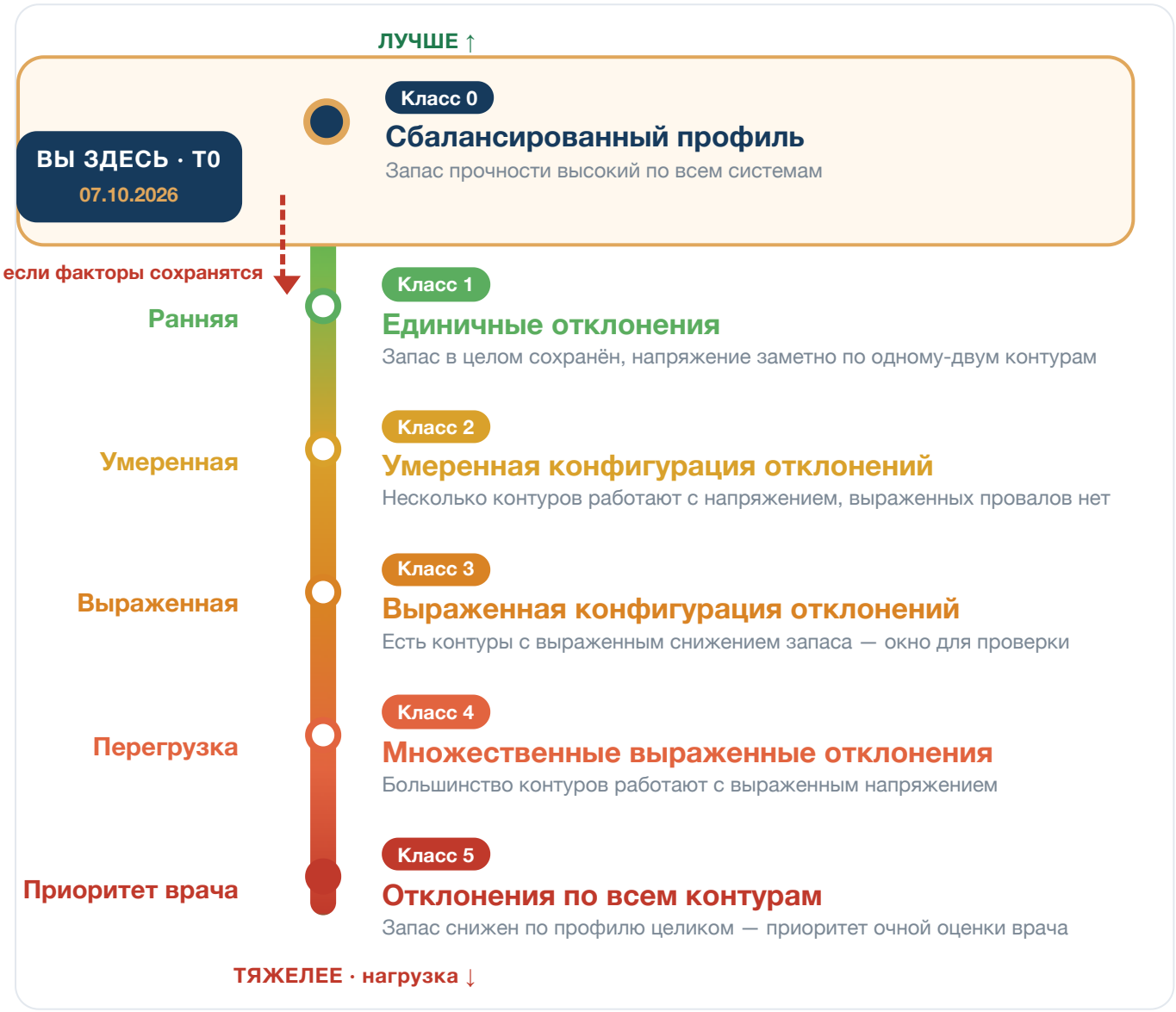
> **Надёжность мочевых данных.** По анкете моча собрана нестандартно (не первая утренняя порция или не в стерильный контейнер). Мочевые показатели в этом отчёте ориентировочные; выводы по моче стоит подтвердить повторным сбором по правилам.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ КОНТИНУУМЕ

Траектория организма

Континуум описывает не болезнь, а способ поддержания равновесия. Точка T0 — где организм сейчас; стрелки — направления, а не предсказание.

Шкала: Класс 0 + 5 классов профиля = 6 зон. Сейчас — Класс 0 · сбалансированный профиль (1-я зона из 6). Это тот же класс, что на обложке врачебной версии отчёта.



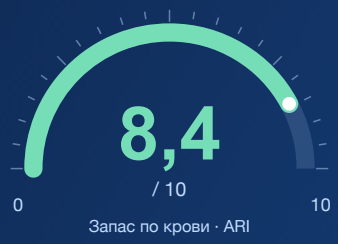
ЧТЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ

Организм — Класс 0 · сбалансированный профиль. Средний запас по шести системам крови — 8,4/10; больше всего напряжения — «кишечник» (5,0/10). Это точка отсчёта для следующего измерения (T0→T1→T2), а не предсказание будущего.

ЧТО ПОКАЖЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА

Что будет дальше, по одной точке не определяется. Направление покажет повторное измерение крови и мочи через 8–12 недель. Наблюдают за системой с наибольшим напряжением: именно её изменение видно между точками.

Ваш общий результат



ОБЩИЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ (ПО КРОВИ)

Хороший запас прочности

Средний запас по шести системам хороший, но общий вывод определяется самыми напряжёнными системами — они разобраны в зонах внимания. Обмен веществ работает с запасом и по крови, и по тому, что выводится с мочой. Задача — сохранить это и не растратить.

Как это обычно ощущается. Обычно такой профиль соответствует хорошей переносимости нагрузки и восстановлению.

Класс 0 0–10 · выше — больше запас

САМАЯ НИЗКАЯ ОЦЕНКА ПО КРОВИ

Кишечник · 5,0 / 10

умеренное напряжение

НАИБОЛЬШИЙ ЗАПАС ПО КРОВИ

Сосуды и доставка кислорода · 10,0 / 10

высокий резерв

Что добавляет моча

Четыре показателя пары материалов

Эти оценки возможны только потому, что вместе с кровью исследована утренняя моча.

SLI



Нагрузка по следам в моче

выше — больше нагрузка

Выводится немного — признаков заметной нагрузки по моче нет.

Насколько много продуктов напряжения обмена организм выводит с утренней мочой.

CLR



Отражается ли напряжение крови в моче

выше — лучше

Расхождений между кровью и мочой почти нет — оценивать здесь нечего, это не плохо.

Сравнение напряжения в крови со следами в утренней моче. Это не оценка работы почек.

CON

1 из 2

Кровь и моча говорят одно и то же?

систем с напряжением в обоих материалах

Большинство сигналов подтверждены и кровью, и мочой.

Сколько систем с напряжением видно сразу в обоих материалах.

DPI



Насколько важен повторный анализ

выше — повтор важнее

Повтор — по плану, для наблюдения во времени.

Чем выше, тем полезнее повторить профиль, чтобы увидеть динамику.

Ваша терапия и диагнозы — читайте отчёт с этой поправкой

Вы указали приём: Релпакс 40 мг (06.10.2026), магний глицинат (доза общая 360), акатинол мемантин (10 мг) - 2 р. за последние 3 дня, L-теанин, витамины B1, B2, B3, B6, B9 (комплекс с дозой до 65 до 75 % от суточной дозы). **Указанные заболевания:** Другое; Мигрень/миотония. Часть сигналов может быть ожидаемым действием терапии или следствием уже известного заболевания, а не новой проблемой. Не меняйте назначения и не начинайте добавки по этому отчёту: врач сопоставит профиль с лечением.

Все оценки рассчитаны по фиксированным правилам из измеренных концентраций — теми же, что во врачебной версии; они описывают функциональное состояние, а не диагноз.

Ваш функциональный портрет

Карта систем организма

Где сосредоточено внимание и что сохраняет ресурс.

Метаболический портрет · кровь



Не анатомическая диагностика

ЗОНЫ ВНИМАНИЯ ПО КРОВИ

Кишечник
кишечник
умеренное напряжение
5,0 /10

СОХРАНЁННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Белок и мышцы
аминокислоты, мышцы
в норме
8,1 /10

Очистка организма
печень, витамины группы B
в норме
8,9 /10

Энергия и «топливо» клеток
митохондрии, сжигание жиров
высокий резерв
9,0 /10

Иммунитет и стресс
иммунитет, воспаление, нервная система
высокий резерв
9,5 /10

Сосуды и доставка кислорода
сосуды, кровоток, почки
высокий резерв
10,0 /10

Кровь · оценка 0–10: **выше — больше функциональный резерв.** Статусы рассчитаны для текущей пробы.

Утренняя моча · следы обмена

0–10 · выше — заметнее след

Энергетический след (цикл Кребса) 0,0 /10 — спокоен	**След молочной кислоты и сахаров** 0,0 /10 — спокоен	**След жиров и кетонов** 0,0 /10 — спокоен
След распада белка 0,6 /10 — спокоен	**След обмена триптофана** 3,6 /10 — заметный	**След «очистки» и антиоксидантной защиты** 0,0 /10 — спокоен
След обмена оксалатов (щавелевой кислоты) 0,0 /10 — спокоен	**След работы кишечных бактерий** 6,3 /10 — высокий	**След обмена нейромедиаторов** 0,0 /10 — спокоен

От «спокоен» до «выраженный» — насколько заметен след; высокий след — не болезнь, а подсказка, что организм активно выводит.

Органы · модельное сравнение

Плазма крови · 0–10

Сердце и сосуды
9,0 /10
высокий резерв
Метаболических признаков нагрузки на сердце и сосуды не видно.

Печень
10,0 /10
высокий резерв
Печень справляется с обменной нагрузкой.

Дыхательная система
7,0 /10
в норме
Признаков метаболической нагрузки на дыхательную систему нет.

Иммунный баланс
8,0 /10
в норме
Иммунный обмен сбалансирован.

Модели сравнивают ваш профиль с профилями людей без признаков заболевания и пациентов с соответствующими заболеваниями. Это оценка сходства метаболических профилей, не вероятность заболевания и не диагноз.

Две главные зоны внимания

Из всех систем мы выделили те, где напряжение сейчас наибольшее и где изменения дадут самый заметный эффект, — а также системы, где кровь спокойна, но в утренней моче есть заметный след. Для каждой — что мы увидели в крови и в моче, что это может значить, чем это не является и что делать. «Что вы можете ощущать» — возможные проявления: их может и не быть.

1. Кишечник

умеренное напряжение · 5,0 / 10 кровь · моча: высокий

Как бактерии кишечника влияют на обмен веществ, сосуды и иммунитет.

Соотношение продуктов кишечных бактерий в крови сдвинуто: полезных сигналов (индолов) меньше, а тех, что нагружают сосуды, — больше. Это самый «управляемый» из сигналов: он меняется питанием за несколько недель.

Что вы можете ощущать: «Не могу разогнаться», «после нагрузки 2–3 дня лежу», «утреннее истощение».

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В КРОВИ

- **TMAO-путь (1,0 / 10)** — бактерии производят больше TMAO — вещества, нагружающего сосуды
- **синтез TMAO — превращение пищевого холина/карнитина бактериями в вещество, нагружающее сосуды** — повышен: бактерии активно производят TMAO

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В УТРЕННЕЙ МОЧЕ

- **След работы кишечных бактерий** — высокий: с мочой выводятся продукты, которые делают бактерии кишечника; их больше при изменении питания, после антибиотиков, на фоне некоторых добавок или при работе кишечника с напряжением

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

- Пищевые волокна и растительное разнообразие — постепенно, отслеживая переносимость.
- Короткий дневник еды и самочувствия: так видно личные триггеры.
- При стойких жалобах со стороны живота обсудите с врачом обследование желудочно-кишечного тракта.

> **Чем это не является.** Это не «дисбактериоз» как диагноз и не повод принимать пробиотики наугад.

2. Иммунитет и стресс

высокий резерв · 9,5 / 10 кровь · моча: заметный

Есть ли в организме скрытое воспаление или хронический стресс, и как это влияет на нервную систему и сон.

В крови эта система спокойна (9,5 / 10), а в утренней моче триптофан — сырьё для серотонина и мелатонина; его продукты в моче показывают, в какую сторону он расходуется. Похоже, организм справляется за счёт выведения; важно понять, откуда эта нагрузка.

Что вы можете ощущать: Утомляемость «не телом, а головой», хуже сон, меньше устойчивости к стрессу, дольше восстановление после простуд.

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В КРОВИ

- **соотношение «хинолиновая кислота / продукт серотонина»** — повышено: больше триптофана уходит в путь воспаления, а не серотонина · показатель-контекст: важен сам факт сдвига, а не его величина
- **серотонин** — повышен

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В УТРЕННЕЙ МОЧЕ

- **След обмена триптофана** — заметный: триптофан — сырьё для серотонина и мелатонина; его продукты в моче показывают, в какую сторону он расходуется

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

- Сон 7–8 часов и в одно время — самое сильное, что можно сделать самому.
- Ограничить кофеин во второй половине дня.
- Расскажите врачу о самочувствии и сне; при затяжной слабости после инфекций попросите оценить воспалительные показатели.

> **Чем это не является.** Это не диагноз воспалительного или аутоиммунного заболевания и не «депрессия». Это повод проверить простые маркеры воспаления и обсудить сон и стресс.

Что сходится и что держится хорошо

ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ С НЕСКОЛЬКИХ СТОРОН

Темы ниже видны сразу в нескольких разделах анализа, и хотя бы один из них — утренняя моча, отдельный материал. Разделы по крови считаются из одних и тех же измерений, поэтому главное здесь — совпадение с мочой. Эти темы удобно обсудить с врачом в первую очередь.

1 Воспаление, стресс и сон подтверждено 3 частями анализа · есть подтверждение мочой

Напряжение иммунной и стрессовой системы видно с нескольких сторон: сон, хронические очаги и стресс стоит разбирать вместе.

2 Кишечник и питание подтверждено 3 частями анализа · есть подтверждение мочой

Вклад кишечных бактерий виден и в крови, и в моче. Питание, клетчатка и работа кишечника — одна тема для разговора с врачом.

ЧТО ДЕРЖИТСЯ ХОРОШО

- **Энергия и «топливо» клеток — в спокойном резерве.** В анализе нет следов того, что энергию телу приходится добывать через силу.
- **Сосуды и доставка кислорода — в спокойном резерве.** Признаков, по которым видно затруднённую доставку кислорода, в анализе сейчас нет.
- **Гибкое переключение между видами топлива.** Тело умеет переходить с одного источника энергии на другой — это про выносливость.

Это ваш ресурс: эти системы сейчас справляются. Они зависят от тех же причин — режима, сна, нагрузки, — поэтому план ниже поддерживает и их.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

Ваш план на 8–12 недель

6 шагов под ваш профиль

Цель этого периода — закрепить то, что уже работает, и мягко подтянуть зоны умеренного напряжения. Это профилактика в самый выгодный момент: изменения небольшие, а эффект накопительный. Выберите два-три пункта и удерживайте их до повторного анализа.

1 **Старт** — Начните с двух-трёх шагов

2 **Регулярность** — Добавляйте постепенно

3 **Через 8–12 недель** — Динамика — с врачом

Ваши действия

Каждый пункт здесь выбран под ваш профиль: рядом написано, с чем он связан.

01 Клетчатка и регулярность стула

Овощи, зелень и цельные крупы ежедневно; отмечайте регулярность и комфорт стула. Бактериям кишечника нужна не добавка, а еда.

Почему: зона внимания «Кишечник» — 5,0 / 10

02 Сон как лечение, а не как остаток дня

7–8 часов, отбой до 23:30, тёмная прохладная комната, без экранов за час до сна. Это самое сильное средство для этого контура.

Почему: след в моче «след обмена триптофана» — заметный

03 Добавить регулярное движение

По анкете активности мало: начните с 20–30 минут ходьбы в день и двух коротких силовых занятий в неделю.

Почему: ваша анкета: активность — сидячий образ жизни, практически нет физической активности

04 Разговор о терапии на приёме

Возьмите к врачу список препаратов и этот отчёт: часть показателей меняется из-за лечения, и это нужно учесть при трактовке. Ничего не отменяйте сами.

Почему: ваша терапия и то, что она меняет в обмене

05 Пищевой дневник за 2–3 дня до повтора

Перед повторным анализом запишите рыбу, морепродукты, красное мясо, яйца и добавки. Без этого часть показателей нельзя правильно прочитать.

Почему: зона внимания «Кишечник» — 5,0 / 10

06 Найти скрытые очаги воспаления

Вспомните и запишите: недавние простуды, зубы, носоглотка, кишечник, недавний приём антибиотиков. Это список для врача, а не повод лечиться самостоятельно.

Почему: след в моче «след обмена триптофана» — заметный

Что уже работает — не теряйте

Белок и мышцы **8,1 / 10 · в норме** Очистка организма **8,9 / 10 · в норме**

Энергия и «топливо» клеток **9,0 / 10 · высокий резерв**

Эти системы сейчас справляются. План выше поддерживает и их, поэтому специально «лечить» их не нужно.

К приёму и повторному анализу

Кровь

- ☐ кровь — в то же время суток, что и в первый раз
- ☐ последний приём пищи за 6–8 часов до забора (не голодать дольше)
- ☐ без алкоголя 48 часов, без новых добавок 7 дней
- ☐ накануне — без интенсивной тренировки и бани

Утренняя моча

- ☐ моча — первая утренняя порция, средняя часть струи, в аптечный стерильный контейнер; перед сбором — гигиена без мыла с отдушкой
- ☐ доставить в тот же день; до доставки хранить в холодильнике, не замораживать
- ☐ накануне — обычное питьё, без «пролива» водой и без ограничения жидкости
- ☐ запишите время сбора и всё, что принимали накануне, включая обезболивающие
- ☐ у женщин — не во время менструации; при простуде или обострении — перенести сбор

Когда: через 8–12 недель после начала изменений, или по рекомендации врача. Если врач попросит подтвердить отдельный след в моче, повтор мочи можно сделать раньше — как только получится повторить те же условия сбора.

О добавках. Эта страница не содержит списка добавок и доз. Любые добавки подбирает врач очно: их уместность зависит от диагноза, сопутствующей терапии и переносимости, а часть из них может усилить уже имеющийся сдвиг. Принесите на приём список всего, что принимаете сейчас.

К кому обратиться и что взять с собой

Шаг 1 — Кардиолог	По главной находке анализа: кишечник. Он оценит жалобы, назначит обычные анализы из списка ниже и решит, нужны ли другие врачи.
Гастроэнтеролог	По результатам первичной оценки: кишечник; По находке анализа в утренней моче: след работы кишечных бактерий.

Если не знаете, с чего начать, — терапевт (врач общей практики) сопоставит отчёт с обычными анализами и направит дальше.

Какие анализы попросить

Это обычные, доступные анализы — они подтверждают или снимают сигналы метаболомного профиля. Окончательный список определяет врач.

- [ ] общий анализ крови
- [ ] общий анализ мочи
- [ ] креатинин крови и расчёт СКФ
- [ ] общий анализ кала (по решению врача)
- [ ] консультация гастроэнтеролога при жалобах
- [ ] СРБ (С-реактивный белок)

Вопросы, которые стоит задать врачу

1. Что в моём случае может стоять за сигналом «кишечник» и как это проверить?
2. Что в моём случае может стоять за сигналом «иммунитет и стресс» и как это проверить?
3. Может ли моя текущая терапия объяснять часть этих отклонений, и нужно ли что-то менять?
4. Какие из отклонений в моём профиле требуют проверки в первую очередь?
5. Какие обычные анализы крови и мочи нужно сделать, чтобы подтвердить или исключить причины?
6. Какой уровень физической нагрузки мне сейчас безопасен?
7. Нужны ли мне добавки, и какие из них противопоказаны при моей терапии?
8. Когда повторить метаболомный анализ крови и мочи, чтобы оценить динамику?

Что взять с собой

- [ ] Этот отчёт и полную версию для врача (MS(PU)-003-T0)
- [ ] Список всех лекарств и добавок, которые вы принимаете
- [ ] Результаты обычных анализов крови и мочи за последний год, если есть
- [ ] Короткий дневник самочувствия, сна и питания за неделю

Когда обращаться к врачу не откладывая

быстрая потеря веса, повышенная температура, кровь в стуле, ночная потливость, выраженная нарастающая слабость.

Это общие признаки, при которых нужна очная оценка, не дожидаясь повторного анализа.